

ALUNO: 231-002794 GABRIELLI DE FARIA DA SILVA

Prova: 26 | 3a Etapa | Biomedicina 7P

Status: APROVADO

NOTA FINAL

95.5 / 100.0

APROVADO

DETALHAMENTO POR QUESTAO

Q	Tema	Resultado	Nota
Q1	V/F - Esporotricose	8/10 corretos	12.0/15.0
Q2	V/F - Paracoccidioidomicose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q3	V/F - Criptococose	9/10 corretos	13.5/15.0
Q4	MCQ - Classificacao das Micoses	Resp: C Gab: C	6.0/6.0
Q5	MCQ - Dermatofitos	Resp: D Gab: D	6.0/6.0
Q6	MCQ - Histoplasmosse	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q7	V/F - Candida spp	10/10 corretos	15.0/15.0
Q8	MCQ - Aspergilose	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q9	MCQ - Dimorfismo Fungico	Resp: D Gab: D	6.0/6.0
Q10	MCQ - Diagnostico Laboratorial	Resp: A Gab: A	6.0/6.0
Q11	MCQ - Triagem Clinica	Resp: C Gab: C	4.0/4.0
TOTAL			95.5/100.0

PARTE I — VERDADEIRO OU FALSO (Q1, Q2, Q3, Q7 — 15 PTS CADA)

Questão 1 — Esporotricose (15,0 pts)

CASO CLÍNICO. A esporotricose é a maior epidemia de micose transmitida por animais registrada no Brasil, com mais de 40.000 casos humanos notificados entre 2013 e 2023, concentrados no RJ, MG e SP. O fungo dimórfico do gênero *Sporothrix* alterna entre bolor (25°C) e levedura (35-37°C). Diferente da forma clássica ("doença do jardineiro"), no Brasil o vetor principal é o **gato doméstico**, que transmite por arranhadura, mordedura ou contato com secreções. Diagnóstico: exame direto (KOH/Gram) + cultura em Sabouraud/Mycosel. Tratamento de 1ª escolha: **itraconazol** oral por 3-6 meses (SUS gratuito). Não se deve abandonar o animal.

Marque V ou F para cada afirmação. Para cada F, reescreva corretamente na Folha de Respostas.

Nº	Afirmação	Pts
1	Causada por fungos do gênero <i>Sporothrix</i> ; classificada como micose subcutânea (inoculação por trauma). V	1,5
2	Transmissão ocorre principalmente por inalação de esporos, semelhante à criptococose. F	1,5
3	No Brasil, o gato doméstico é o principal vetor (arranhadura, mordedura, secreções). V	1,5
4	A forma clássica e a forma zoonótica brasileira possuem o mesmo mecanismo de transmissão. F	1,5
5	Dimórfico: bolor a 25°C no ambiente, levedura a 35-37°C no hospedeiro. V	1,5
6	Para cultura, o fungo cresce exclusivamente a 37°C, não em temperatura ambiente. V	1,5
7	Amostras: pus/biópsia. Exames: direto (KOH/Gram) + cultura (Sabouraud/Mycosel). V	1,5
8	Tratamento de 1ª escolha da forma linfocutânea: anfotericina B IV. F	1,5
9	Itraconazol oral 3-6 meses é o tratamento de 1ª escolha, fornecido pelo SUS. V	1,5
10	Orientação correta: abandonar o gato para evitar transmissão. F	1,5

Questão 3 — Criptococose (15,0 pts)

MENINGOENCEFALITE NO HIV/AIDS. A criptococose é infecção fúngica oportunista que causa meningoencefalite grave, sendo a 2ª infecção fúngica que mais mata pessoas com HIV/AIDS (letalidade 45-65%). O fungo *Cryptococcus* possui **cápsula polissacarídica** (escudo protetor) presente tanto no ambiente quanto no corpo. A transmissão **NÃO é por contato com pombo** — ocorre por **inalação de partículas do fungo** em poeira contaminada com fezes de aves. Atinge imunocomprometidos, mas não só HIV+ (também transplantados, etc.). Diagnóstico: **tinta da China** (halo claro ao redor da cápsula), cultura, antígeno criptocócico. Tratamento: **3 fases** (indução com anfotericina B + flucitosina, consolidação, manutenção com fluconazol), gratuito pelo SUS, por >1 ano. Profilaxia com fluconazol para HIV+ com CD4 baixo.

Marque V ou F. Para cada F, corrija na Folha de Respostas.

Nº	Afirmação	Pts
1	<i>Cryptococcus</i> tem cápsula-escudo, presente tanto no ambiente quanto no corpo. V	1,5
2	Pega-se a doença por encostar em pombo e suas penas. F	1,5
3	Principal forma: inalar partículas do fungo em poeira contaminada. V	1,5
4	Doença oportunista — aproveita defesa fraca (HIV/AIDS, transplantados). V	1,5
5	Só pega a doença quem tem HIV. F	1,5
6	Tinta da China mostra a cápsula do fungo como halo claro. V	1,5
7	Diagnóstico só pode ser feito pela tinta da China. F	1,5
8	Tratamento em 3 fases (indução, consolidação, manutenção), pelo SUS. V	1,5
9	Tratamento inicial: fluconazol sozinho. F	1,5
10	Todo HIV+ deve tomar fluconazol preventivo. V	1,5

Questão 4 — Classificação das Micoses (6,0 pts)

Micoses são classificadas conforme a profundidade de invasão tecidual: **superficiais** (camada córnea), **cutâneas** (epiderme e anexos pilosos), **subcutâneas** (tecidos profundos da pele) e **sistêmicas** (órgãos internos). Micoses **oportunistas** afetam principalmente imunocomprometidos, embora possam ocorrer em imunocompetentes. Adotada no Brasil por SBM, SBMT e MS.

Sobre a classificação clínico-patológica das micoses humanas, assinale a alternativa correta:

- **C** Criptococose, Candidíase e Aspergilose são micoses oportunistas, pois afetam predominantemente imunocomprometidos, embora possam ocorrer em imunocompetentes. **V**
- A** Dermatofitose (Tineas) é micose superficial, pois o fungo invade o sistema nervoso central, podendo disseminar-se pela via linfática. **F**
- B** A Esporotricose é micose subcutânea cuja principal porta de entrada é a inalação de esporos, com posterior disseminação hematogênica. **F**
- D** Histoplasmosse é micose cutânea, com lesões dermatológicas como manifestação mais frequente e a pele como porta de entrada. **F**
- E** Micoses sistêmicas (Histoplasmosse, Coccidioidomicose, Paracoccidioidomicose) têm como principal porta de entrada a inoculação traumática na pele. **F**

Questão 2 — Paracoccidioidomicose (15,0 pts)

MICOSE SISTÊMICA ENDÊMICA. A paracoccidioidomicose (PCM) é a principal micose sistêmica da América Latina, com o Brasil concentrando cerca de 80% dos casos mundiais. O fungo *Paracoccidioides* é dimórfico (bolor no solo — levedura nos tecidos a 37°C). A transmissão ocorre por **inalação de poeira contaminada** durante atividades agrícolas (arar, capinar) — **NÃO pelo tatu**, que apenas se infecta da mesma forma. Atinge principalmente homens adultos rurais (30-60 anos, ~90% dos casos). Forma crônica (lenta, com lesões pulmonares e bucais) é a mais comum. Diagnóstico: microscopia de escarro/lesão + cultura. Tratamento: antifúngico oral fornecido pelo SUS. Ocorre em várias regiões do Brasil, não só no Norte.

Marque V ou F. Para cada F, corrija na Folha de Respostas.

Nº	Afirmação	Pts
1	O fungo tem aspecto diferente no solo e no corpo humano (dimorfismo). V	1,5
2	Transmitida por mordedura ou arranhadura do tatu. F	1,5
3	Contaminação ao respirar poeira do solo durante trabalho rural. V	1,5
4	Forma mais comum em adultos: crônica (lenta), com pulmão e boca afetados. V	1,5
5	Atinge principalmente homens 30-60 anos rurais (~90% dos casos). V	1,5
6	Diagnóstico é feito apenas por exame de sangue. F	1,5
7	Exame microscópico de escarro/lesão bucal ajuda no diagnóstico. V	1,5
8	O único tratamento é cirúrgico. F	1,5
9	Tratamento com antifúngico oral fornecido pelo SUS. V	1,5
10	Doença restrita à região Norte do Brasil. F	1,5

2.2 (F) - Transmissão por inalação de poeira contaminada

2.6 (F) -

Questão 7 — *Candida* spp. (15,0 pts)

DO COMENSALISMO À AMEAÇA HOSPITALAR. *Candida albicans* vive como comensal em 40-60% das pessoas saudáveis (boca, intestino, genitália). Desequilíbrios (imunidade baixa, antibióticos prolongados, diabetes, gravidez) podem causar desde **candidíase vulvovaginal** (3 em cada 4 mulheres) até **candidemia** (sangue), com mortalidade 40-60%. *C. albicans* muda de forma (levedura arredondada → filamentososa alongada), o que facilita invasão tecidual. Já *Candida auris* (identificada em 2009 no Japão, 1º caso brasileiro em Salvador/BA em 2020) é **multirresistente**, sobrevive semanas em superfícies e é difícil de identificar em laboratórios comuns — CDC classifica como "ameaça urgente". **Transmissão hospitalar: por contato** (mãos dos profissionais, equipamentos), **NÃO pelo ar**. Prevenção: higiene rigorosa das mãos e limpeza de superfícies.

Marque V ou F. Para cada F, corrija na Folha de Respostas.

Nº	Afirmação	Pts
1	<i>C. albicans</i> vive naturalmente em pessoas saudáveis, sem causar doença. V	1,5
2	<i>C. albicans</i> muda de forma (arredondada → alongada) para invadir tecidos. V	1,5
3	Candidíase vaginal: comum com antibióticos, gravidez e diabetes. V	1,5
4	<i>C. auris</i> : multirresistente, sobrevive em superfícies, difícil identificação. V	1,5
5	Transmissão hospitalar: por contato, não pelo ar. V	1,5
6	<i>C. albicans</i> se pega pelo ar, como gripe/COVID. F	1,5
7	<i>C. auris</i> é facilmente tratada com fluconazol. F	1,5
8	<i>C. auris</i> foi descoberta no Brasil (Salvador) em 2020. V	1,5
9	Prevenção principal: vacinar todos os pacientes internados. F	1,5
10	<i>C. auris</i> é perigosa por formar esporos suspensos no ar. V	1,5

Questão 5 — Dermatofitos (6,0 pts)

Os dermatofitos são fungos que causam infecções em tecidos queratinizados — pele, pelos e unhas — as dermatofitoses ou **Tineas**. Esses fungos produzem queratinases que digerem a queratina e invadem o estrato córneo. O diagnóstico é feito pelo exame direto com KOH (visualização de hifas septadas) e cultura em ágar Sabouraud. O tratamento inclui antifúngicos tópicos (terbinafina, clotrimazol) e sistêmicos para casos extensos.

Criança, 7 anos, apresenta lesão circular descamativa no couro cabeludo, com 3 cm de diâmetro, borda elevada e clareamento central há 2 semanas. A mãe relata contato com filhote de gato. O exame direto com KOH mostrou hifas septadas ramificadas. Qual o diagnóstico e o método laboratorial que o confirmou?

- A** Impetigo bacteriano; cultura em ágar sangue mostrou cocos Gram-positivos. **F**
- B** Dermatofitose (*Tinea capitis*); exame direto com KOH visualizou hifas septadas, características de dermatofitos. **V**
- C** Candidíase cutânea; exame mostrou leveduras broqueantes. **F**
- D** Dermite seborreica; diagnóstico clínico, sem confirmação laboratorial. **F**
- E** Psoríase do couro cabeludo; biópsia de pele confirmou. **F**

1) 1.2 (F) - Transmissão ocorre por arranhadura, mordedura ou contato com secreção.

1.8 (F) - 1ª escolha de tratamento é o itraconazol oral

1.10 (F) - Não se deve abandonar o animal